

对美沙酮药物相互作用的探讨

耿光伟

(江苏南京市职业病防治院美沙酮维持治疗门诊, 江苏 南京 210032)

【摘要】目前,美沙酮药物维持治疗患者大量存在服用或滥用几种药物现象,这种现象的发生会使得各种药物之间出现相互作用的情况,进而引发许多不良症状,美沙酮药物与其他药物的相互作用主要体现在三个方面,其中包括药效学、药剂学以及药动学,在临床医学中,我们主要是研究美沙酮药物和其他药物在药动学上的作用情况,具体来说是研究药物的代谢情况、吸收情况以及分布情况,目前药物相互作用在代谢方面指数达到了40%^[1]美沙酮药物的特殊性质和不良反应,因美沙酮药物维持治疗门诊需特别关注。患者的死亡90%是合并使用其他用药^[2]

【关键词】美沙酮;相互作用;不良反应

【中图分类号】R95

【文献标识码】A

【文章编号】ISSN.2095-8242.2019.85.164.02

DOI:10.16281/j.cnki.jocml.2019.85.147

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2017年5月对40例患者随机问卷调查,调查患者所患基础疾病用药情况,合并用药情况,合用药物的种类,饮酒情况,滥用其他毒品情况,在维持治疗门诊是否告知合并用药情况,以及出现的不良反应情况。

1.2 方法

通过统计、比较、分析患者合并用药(毒品、酒)的状况。

2 结果

40例患者中,所患疾病为结核病、脑梗塞、哮喘、糖尿病、失眠、高血压、肝腹水、精神分裂症、慢性胃炎、慢性支气管炎、宫颈癌、乙肝、冠心病、肠息肉、艾滋病、肾炎、胃溃疡等多种疾病,患有基础疾病40例(100%),合并用药(毒品、饮酒)患者36例(90%),用药品种37种药品,其中对美沙酮有药效学和药动学有影响的,13种药品(抗高血压药5种,利尿剂2种,中枢抑制药4种,抗结核药1种,抗病毒药1种),合并用药未告知医生的患者33人(占82.5%)其中饮酒2例,药物滥用2例,在37种药品中,明确影响美沙酮代谢的利福平^[3]、卡马西平^[4]、异烟肼、酒精^[5]、拉夫米定等。

3 讨论

美沙酮维持治疗海洛因成瘾者的维持治疗,从问卷调查中可以发现对美沙酮合并用药的患者并发症高,合并用药种类多,其中有饮酒患者,药物滥用,合并用药对美沙酮主要影响表现为药效学、药动学的方面,具体为:(1)对美沙酮药效学影响,和美沙酮药物相互作用对人体中枢起到抑制作用的药物包括三环类抗抑郁药、麻醉性镇痛药、吩噻嗪类药剂等,因此这些药物共同使用时,我们需要减少美沙酮的剂量。从药效上看,美沙酮药剂能够发挥出一定降血压的作用,当患者服用美沙酮和其他药物时,就会引起严重低血压反应。阿片受体拮抗剂纳

络酮、纳曲酮等可诱发严重的戒断症状。特点是临床医生不难判断。

(2)对美沙酮药动学的影响,肝药酶P450,该药物会改变药物的药动学,进而使药效发生变化,还可能降低药物的代谢效率,进而增加药物的毒性,加重患者的病情,引发严重的后果,美沙酮受肝药酶CYP1B6和CYP2C19代谢,影响CYP1B6和CYP2C19(如奥美拉唑)将影响美沙酮的代谢。而通过以上两种CYP的代谢的药物,也将受到影响,特点是临床医生很难判断。

①对美沙酮肝药酶诱导剂影响的药物,这类药物会降低美沙酮的治疗效果,比如说:卡马西平、利福平、乙醇等药物能够在一定程度上强化患者肝细胞的微粒体酶活性,进而促进了美沙酮的转化,让药物的排泄效率加快,降低了美沙酮药物的镇痛效果。除此之外,美沙酮还能够强化肝脏的首过反应、这样无疑降低了美沙酮的利用率,进而引发戒断症状。容易引起戒断反应的药物包括纳曲酮、阿片受体拮抗剂等,药物的剂量将直接决定酶诱导的程度。

②抗逆转录病毒药物为肝药酶抑制剂,使美沙酮代谢减慢,与美沙酮相互作用有可能导致戒断症状的出现或者美沙酮相对过量^[6],P450酶抑制可以将药物分为两类,一种为可逆,另一种为不可逆,最常见的是可逆性,通过动力学方法可将其分为竞争性、非竞争性或反竞争性,如果将药物和美沙酮同时服用,经过肝脏代谢后,血药的浓度会比单服美沙酮的时候搞,最主要的原因是由于它是基于竞争性酶抑制而不需要合成新的酶,酶抑制相互作用的临床意义取决于美沙酮血清浓度升高的水平,如果血药浓度仍在治疗范围内,就会变成不良相互作用。

(3)血浆蛋白结合率,高的药物,可与美沙酮竞争血清蛋白,减慢美沙酮的代谢,造成美沙酮的蓄积,或可能产生不良反应。

(4)与其它药物的相互作用,当美沙酮和苯丙胺类联合应用时,可能引起迟发性运动障碍。与女性避孕药合用,可出现乏力、困倦等反应。与酒精合用,可造成意

(下转166页)

2.2 两组患者不良反应及复发情况

观察组出现1例头晕,不良反应发生率为2.63%(1/38),对照组出现1例头晕,1例皮疹,不良反应发生率为5.26%(2/38),观察组与对照组的不良反应发生率无显著差异($P>0.05$)。追踪1月,观察组复发率为5.26%(2/38),对照组复发率为13.16%(5/38),两组的复发率无显著差异($P>0.05$),两组复发患者经住院治疗均已康复。

3 讨论

胃痞作为中医病名诊断,是指中焦气机不畅,脾胃升降失常,引起以心下痞满,食少纳呆,按之柔软,压之无痛为主要临床表现的疾病。可见于西医的多种消化系统疾病及其他系统病变累及消化系统,故不宜对等西医某项单一病变,难以以西医某项检查进行统一评判。西医进行对症治疗,主要包括控制胃酸、缓解疼痛、增强胃动力等等,本文应用的是雷贝拉唑和莫沙必利二联用药方案,雷贝拉唑作为质子泵抑制剂,能减少胃酸分泌,调节胃内pH值,莫沙必利则是一种碱性促胃肠动力药物,可以加速胃排空,避免胃部反酸,二者联合可以发挥协同作用,促进胃黏膜的修复^[4]。但是雷贝拉唑和莫沙必利二联用药方案,部分患者症状缓解不佳,且长时间应用破坏肠道菌群使不良反应增多,还会产生耐药性,停药后复发的概率较大,造成症状反复发作、久治不愈。淮安市名老中医徐承祖认为,胃痞病可由起居、饮食、情志、药物等多方面因素诱发,但均导致了脾胃升降失常,虚实相兼,寒热错杂。因此,治疗胃痞病的重点在于调和脾胃,寒热并治。经多年临证经验,自拟十八味消痞方作为胃痞病的专病专治。本方取自《伤寒论》之半夏泻心汤,君药半夏具有和胃消痞、降逆化痰的功效,臣药黄连、黄芩清热祛湿,干姜温中除痞,党参、大枣健脾养血,使药甘草调和诸药,共同发挥散结降逆、消痞养胃的药用功效^[5]。在此基本方的基础上,加强行气化湿以健脾,健胃消食以除痞,药物有:厚朴、枳实、木香、砂仁、白术、茯苓、藿香、佩

兰、神曲、麦芽、鸡内金等,并根据患者的寒热虚实偏胜以及是否兼夹吐酸嘈杂等具体情况分别加味。痞满的病机多为虚实夹杂,可因实致虚,又可因虚致实,并不是单纯的非寒即热、非虚即实、非阴即阳、非表即里。谨守病机,治病求本。十八味消痞方集平调寒热、辛开苦降、消补兼施三法于一方,专病专方,随证加减,执简驭繁,充分体现了中医辨证论治的原则性和灵活性。需要指出的是,吾师徐老在诊治胃病的过程中,十分强调对每一位病人开出的第一张处方不是药物处方,而是口头或书面的非药物处方,即对就诊病人进行健康教育和生活方式干预。徐老认为,中医传统理论就是“肝主疏泄”,“脾主运化”,暴怒、情志抑郁以及思虑过度均可导致脾胃升降功能的失常。还有“以酒为浆,以妄为常”,“饮食自倍,肠胃乃伤”等论述,又强调了饮食习惯、生活方式对脾胃升降的影响。因此,徐老认为:规劝就诊病人调整心态,怡情养性,同时改变不良生活方式和不合理的饮食习惯,能起到药物不能替代的治疗和防复发的作用。我们临床跟师时,徐老常常告诫我们:“对于慢性胃病,医生治一半,病人自己治一半。”诚经验之谈,也是中医特色之所在。综上所述,中药十八味消痞方在胃病治疗中的应用效果良好,可以显著改善患者的痞满症状。

参考文献

- [1] 张伟,姜锐,王璐.中药半夏泻心汤治疗慢性胃炎伴幽门螺杆菌感染的疗效及安全性分析[J].辽宁中医杂志,2018,45(07):1424-1426.
- [2] 苟锡凯.半夏泻心汤联合西医三联疗法治疗慢性胃炎临床效果观察[J].医药前沿,2019,09(14):69-70.
- [3] 陈俊唐,胡明丽.半夏泻心汤加减治疗慢性胃炎的临床观察[J].光明中医,2018,33(16):2387-2389.
- [4] 滕凌,陈治林.雷贝拉唑联合莫沙必利治疗慢性胃炎的疗效及安全性观察[J].北方药学,2019,16(07):138-139.
- [5] 王月新,武迎军.半夏泻心汤联合西药三联疗法治疗慢性胃炎66例[J].中国药业,2014,23(16):123-125.

本文编辑:吴卫

(上接164页)

外伤亡。

综上所述,美沙酮药剂,并发症多,合并用药比例高,对患者疾病治疗或美沙酮的治疗,产生不良影响或潜在的不良影响,影响美沙酮的正常维持治疗或影响患者的基础疾病的治疗,肝药酶P450对药物代谢复杂,肝药酶抑制药对美沙酮的影响应特别重视,临床医生要反复充分告知患者合并用药的风险,需要了解患者合并用药情况,从不同渠道获取已知的美沙酮合并用药的不良反应,及时调整治疗方案,应及时上报在合并用药过程中出现的不良反应/不良事件,要充分认识到滥用药物的危害性,尤其是因患者不告知,失误造成的药物之间相互作用可能引起的不

良反应。美沙酮合并用药的不良反应应进一步探讨。

参考文献

- [1] 邹文,周文.食品与药品,2007,9,12A.
- [2] 张锐敏.国家级美沙酮维持治疗培训中心.
- [3] 贾秀云,丁以星.中国防痨杂志,2009,6,31(6).
- [4] 曾友志.《第七届全国药物依赖性学术会议论文摘要汇编》,2003.
- [5] 董维红,冯胜启.中国药物滥用防治杂志,2006,23.
- [6] 罗俊,潘佩佩.中国药物滥用防治杂志,2017,5.

本文编辑:吴卫